TÉCNICA DE MCLAUGHLIN NA LUXAÇÃO POSTERIOR INVETERADA DO OMBRO DIREITO COM LESÃO DE HILL-SACHS REVERSA: RELATO DE CASO

Expedito Alves Rodrigues Neto[1]; Emanuele Cristhina Nóbrega Gomes[2]; Enzo Lima Coelho[1]; Vitor Carvalho Barroso[3] (orientador)

[1] Universidade Federal do Maranhão (UFMA), São Luís, MA, Brasil
[2] Faculdade IDEA, Brasil
[3] Hospital de Traumatologia e Ortopedia (HTO), São Luís, MA, Brasil

Autor para correspondência: Expedito Alves Rodrigues Neto · expeditoalvesnt@gmail.com

RESUMO

A luxação posterior do ombro é rara, correspondendo a 2–5% das luxações glenoumerais, sendo frequentemente subdiagnosticada e podendo evoluir para quadros negligenciados de longa duração. Quando associada a fratura por impactação da face anteromedial da cabeça umeral (lesão de Hill-Sachs reversa), o tratamento cirúrgico é indicado nos casos com comprometimento articular significativo, sendo a técnica de McLaughlin uma opção para restaurar a estabilidade glenoumeral. Objetiva-se relatar um caso de luxação posterior negligenciada do ombro, com lesão de Hill-Sachs reversa, tratada pela técnica de McLaughlin. Paciente do sexo masculino, 32 anos, com instabilidade glenoumeral recorrente bilateral e episódios prévios de resolução espontânea, evoluiu com luxação posterior do ombro direito durante episódio habitual que, dessa vez, não apresentou redução espontânea; buscou atendimento médico inicial sem diagnóstico correto, sendo encaminhado à fisioterapia sem melhora e permanecendo luxado por cerca de 10 semanas até o diagnóstico correto. Ao exame pré-operatório, apresentava escore visual analógico de dor (EVA) de 7, elevação ativa de 50°, rotação externa de −10° (bloqueio) e rotação interna limitada, alcançando apenas a região glútea. A tomografia computadorizada evidenciou luxação posterior glenoumeral com perda da congruência articular e defeito de impactação cortical anteromedial compatível com lesão de Hill-Sachs reversa, envolvendo 27% da superfície articular da cabeça umeral, sem fratura deslocada da glenoide. Foi submetido a tratamento cirúrgico com técnica de McLaughlin por via aberta, seguida de imobilização com tipoia Velpeau e coxim de abdução em posição neutra por 6 semanas e fisioterapia. No seguimento de aproximadamente 3 meses, evoluiu com melhora clínica e funcional, confirmada por tomografia de controle sem derrame articular e com osteossíntese em posição adequada, apresentando redução do EVA (7 para 1) e ganho de elevação ativa (50° para 90°), rotação externa (−10° para 30°) e rotação interna (glútea para L1). A técnica de McLaughlin mostrou-se eficaz para o tratamento da luxação posterior negligenciada com lesão de Hill-Sachs reversa, restaurando a estabilidade glenoumeral e o retorno funcional, reforçando a importância do diagnóstico precoce dessa condição.

Palavras-chave: Luxação do ombro; Relatos de casos; Procedimentos ortopédicos.

ABSTRACT

Mclaughlin technique in neglected posterior right shoulder dislocation with reverse Hill-Sachs lesion: case report

Posterior shoulder dislocation is rare, accounting for 2–5% of glenohumeral dislocations, and is frequently underdiagnosed, which may lead to long-standing neglected cases. When associated with an impaction fracture of the anteromedial aspect of the humeral head (reverse Hill-Sachs lesion), surgical treatment is indicated in cases with significant joint involvement, and the McLaughlin technique is an option to restore glenohumeral stability. The objective is to report a case of neglected posterior

shoulder dislocation with a reverse Hill-Sachs lesion treated with the McLaughlin technique. A 32-year-old male patient with recurrent bilateral glenohumeral instability and previous episodes of spontaneous resolution developed a posterior dislocation of the right shoulder during a usual episode that, this time, did not reduce spontaneously; he sought initial medical care without a correct diagnosis and was referred to physiotherapy without improvement, remaining dislocated for about 10 weeks until the correct diagnosis. On preoperative examination, he had a visual analog scale (VAS) pain score of 7, active elevation of 50°, external rotation of −10° (locked) and limited internal rotation, reaching only the gluteal region. Computed tomography (CT) showed posterior glenohumeral dislocation with loss of joint congruity and an anteromedial cortical impaction defect consistent with a reverse Hill-Sachs lesion, involving 27% of the articular surface of the humeral head, without a displaced glenoid fracture. He underwent surgical treatment with the McLaughlin technique through an open approach, followed by immobilization with a Velpeau sling and an abduction pillow in neutral position for 6 weeks, and physiotherapy. At approximately 3 months of follow-up, he showed clinical and functional improvement, confirmed by follow-up CT with no joint effusion and with the osteosynthesis in adequate position, with a reduction in VAS score (7 to 1) and gains in active elevation (50° to 90°), external rotation (−10° to 30°) and internal rotation (gluteal region to L1). The McLaughlin technique proved effective for the treatment of neglected posterior dislocation with a reverse Hill-Sachs lesion, restoring glenohumeral stability and functional return, and reinforcing the importance of early diagnosis of this condition.

Keywords: Shoulder dislocation; Case reports; Orthopedic procedures.

1 INTRODUÇÃO

A luxação posterior do ombro é uma lesão rara, que corresponde a cerca de 2 a 5% das luxações glenoumerais (UPPAL *et al.*, 2016; XIONG *et al.*, 2023). Suas causas clássicas são as crises convulsivas, os traumas de alta energia, o choque elétrico e a eletroconvulsoterapia (HAWKINS *et al.*, 1987; ROBINSON; ADERINTO, 2005). Por ser pouco frequente e de apresentação clínica discreta, é frequentemente subdiagnosticada na avaliação inicial: na série de Hawkins *et al.* (1987), o primeiro médico que atendeu o paciente não fez o diagnóstico na maioria dos casos, e o intervalo médio até o diagnóstico foi de cerca de um ano. Revisões sistemáticas estimam que 50% a 79% das luxações posteriores passam despercebidas na apresentação inicial (KELLY *et al.*, 2019). Devem levantar a suspeita a dor com ausência de rotação externa e de abdução, sobretudo após crise convulsiva, choque elétrico ou queda, e a confirmação depende de radiografia no plano da escápula e, muitas vezes, de tomografia (HATZIS *et al.*, 2001).

Quando a luxação se mantém, a cabeça do úmero se impacta contra a borda posterior da glenoide e forma um defeito na face anteromedial, conhecido como lesão de Hill-Sachs reversa. Quanto maior o defeito e mais tardio o diagnóstico, pior tende a ser o prognóstico, e a necessidade de artroplastia é um fator associado a resultados menos favoráveis (ROBINSON; ADERINTO, 2005). Os defeitos pequenos e que não engajam na glenoide podem ser tratados sem cirurgia, os maiores que 20% costumam exigir cirurgia, e a artroplastia é em geral necessária quando mais de 45% a 50% da cartilagem articular está comprometida (VAN DER LIST; WATERMAN, 2024). Nos defeitos de tamanho intermediário, as técnicas que preservam a articulação, como a descrita por McLaughlin em 1952 e as suas modificações, buscam preencher o defeito com tecido da própria articulação, seja o tendão do músculo subescapular, seja o tubérculo menor com o tendão, e fixá-lo com parafusos e/ou âncoras (SHEVATE *et al.*, 2023; VELASQUEZ GARCIA, 2022; XIONG *et al.*, 2023).

Por serem raros os casos negligenciados, não há padrão de tratamento estabelecido, e a literatura é formada, em sua maior parte, por séries pequenas e relatos de caso (ROBINSON; ADERINTO, 2005; SHEVATE *et al.*, 2023). Revisões sistemáticas confirmam que não há tratamento de referência (BASAL; DINCER; TURK, 2018) e que a literatura sobre a técnica de McLaughlin modificada é escassa (BERK *et al.*, 2024). Nesse contexto, a descrição detalhada de cada caso agrega informação sobre a técnica e o seguimento. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de luxação posterior negligenciada do ombro direito, com lesão de Hill-Sachs reversa, tratado pela técnica de McLaughlin modificada.

2 RELATO DE CASO

2.1 História clínica

Paciente do sexo masculino, 32 anos, com instabilidade glenoumeral recorrente bilateral e episódios prévios em que o ombro retornava espontaneamente à posição. Em um novo episódio, o ombro direito luxou posteriormente e, dessa vez, não reduziu de forma espontânea. O paciente buscou atendimento médico, mas não recebeu o diagnóstico correto e foi encaminhado à fisioterapia, sem melhora. O ombro permaneceu luxado por cerca de 10 semanas, até o diagnóstico correto.

2.2 Exame físico e exames de imagem

No exame pré-operatório, o paciente referia dor de intensidade 7 na escala visual analógica (EVA). A elevação ativa era de 50°, a rotação externa de −10°, caracterizando bloqueio, e a rotação interna era limitada, alcançando apenas a região glútea.

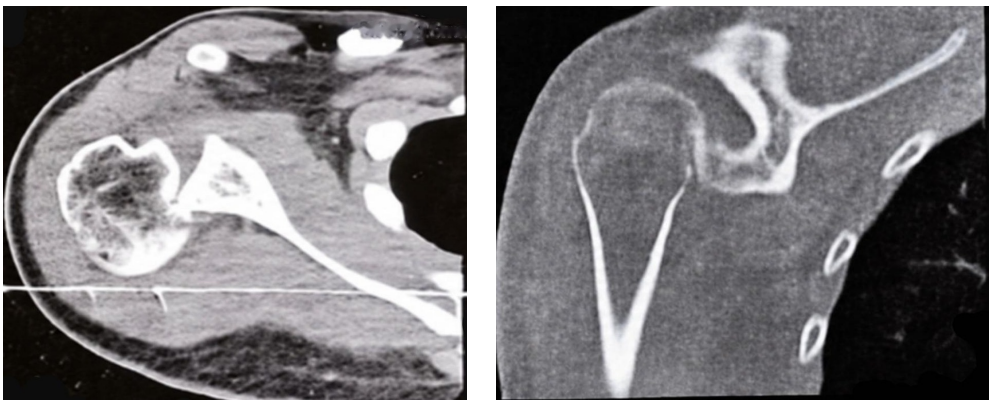
A tomografia computadorizada (TC), realizada em 26/03/2026, confirmou a luxação posterior glenoumeral, com perda da congruência articular (Figuras 1 e 2). Havia defeito de impactação cortical anteromedial na cabeça umeral, compatível com lesão de Hill-Sachs reversa, que envolvia 27% da superfície articular, sem fratura deslocada da glenoide.

Figura 1 – Reconstrução tridimensional da tomografia computadorizada pré-operatória do ombro direito (26/03/2026), em vista lateral. P: posterior; A: anterior.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

Figura 2 – Tomografia computadorizada pré-operatória do ombro direito (26/03/2026): (A) corte axial e (B) corte coronal, com luxação posterior glenoumeral e defeito anteromedial na cabeça umeral.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

2.3 Tratamento cirúrgico

O paciente foi submetido à técnica de McLaughlin modificada, por via aberta, com os seguintes tempos:

(1) Acesso. Foi realizado acesso deltopeitoral, com a veia cefálica como referência do intervalo entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, afastada para lateral.

(2) Osteotomia do tubérculo menor. Realizou-se a osteotomia do tubérculo menor, inserção do tendão do subescapular. Segundo a equipe cirúrgica, apenas esse tempo já permitiu a redução da luxação.

(3) Preparo do leito. O defeito ósseo da cabeça umeral e o tubérculo menor foram curetados até a obtenção de osso sangrante, para favorecer a integração óssea.

(4) Âncoras. Foram fixadas duas âncoras no defeito, cujos fios de alta resistência e inabsorvíveis (*fiber*) foram amarrados ao tendão do subescapular.

(5) Fixação do tubérculo menor. O tubérculo menor foi posicionado no defeito e fixado com dois parafusos corticais de 3,5 mm de espessura e 26 mm de comprimento.

Os dois métodos de fixação foram associados para aumentar a resistência da montagem. Foram usados dois parafusos porque, com apenas um, o fragmento do tubérculo menor poderia rodar. No pós-operatório, o paciente foi mantido com tipoia Velpeau e coxim de abdução em posição neutra por 6 semanas, seguido de fisioterapia.

2.4 Seguimento e resultados

Com cerca de 3 meses de seguimento, o paciente apresentou melhora clínica e funcional, resumida na Tabela 1. A dor reduziu de 7 para 1 na EVA, a elevação ativa aumentou de 50° para 90°, a rotação externa passou de −10° (bloqueada) para 30° e a rotação interna, que alcançava a região glútea, passou a alcançar L1 (Figura 5).

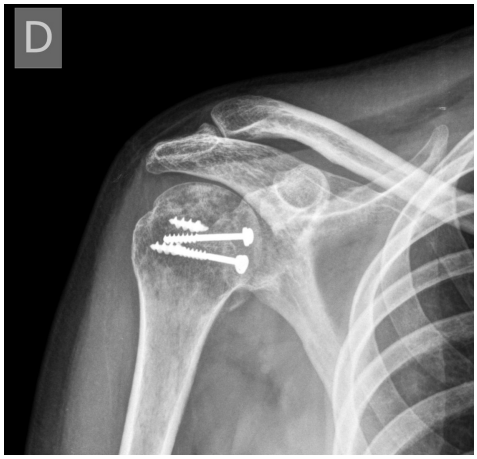
Tabela 1 – Evolução clínica e funcional do paciente, antes do tratamento e com cerca de 3 meses de seguimento.

Parâmetro	Pré-operatório	Seguimento (~3 meses)	Variação
Dor (EVA)	7	1	−6
Elevação ativa	50°	90°	+40°
Rotação externa	−10° (bloqueio)	30°	+40°
Rotação interna	Região glútea	L1	Melhora

Fonte: Acervo dos autores (2026).

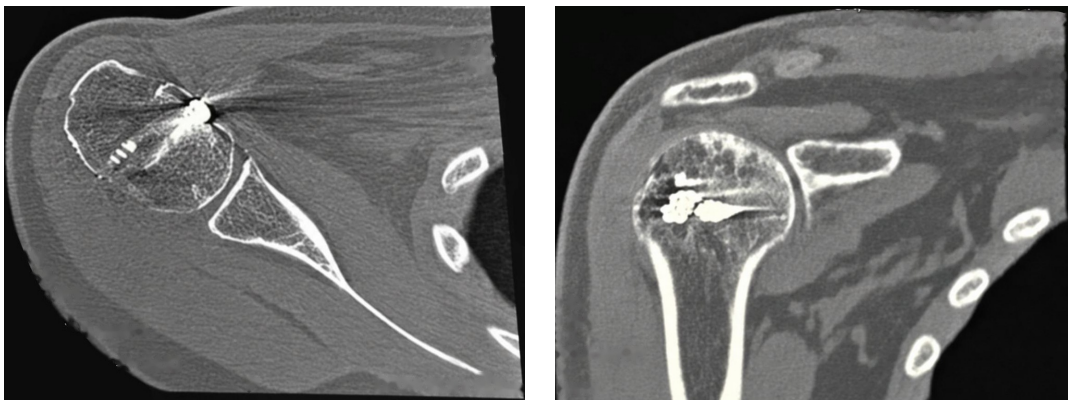
O raio-x pós-operatório, de 21/05/2026, mostrou o material de fixação na cabeça umeral (Figura 3). A TC de controle, de 25/06/2026, confirmou o material de osteossíntese metálico, com as articulações glenoumeral e acromioclavicular conservadas, ausência de derrame articular e trofismo muscular habitual (Figura 4). O laudo descreve irregularidades corticais e subcondrais na superfície anterior da cabeça umeral, que serão acompanhadas no seguimento.

Figura 3 – Radiografia pós-operatória do ombro direito, em incidência anteroposterior (21/05/2026), com material de fixação na cabeça umeral.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

Figura 4 – Tomografia computadorizada de controle do ombro direito (25/06/2026): (A) corte axial e (B) corte coronal, com material de osteossíntese metálico na cabeça umeral, sem derrame articular.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

Figura 5 – Seguimento clínico, com cerca de 3 meses: (A) abdução dos membros superiores, em vista superior, (B) rotação interna com a mão às costas e (C) cicatriz cirúrgica. Rostos ocultados para preservar a identidade do paciente.



Fonte: Acervo dos autores (2026).

3 DISCUSSÃO

Atraso diagnóstico. O caso reproduz o padrão descrito na literatura: um paciente com instabilidade prévia, uma luxação que não reduziu e um atendimento inicial sem diagnóstico, que o levou à fisioterapia. O ombro permaneceu luxado por cerca de 10 semanas, tempo próximo ao intervalo médio entre a lesão e a cirurgia de 11,6 semanas relatado por Xiong *et al.* (2023) em cinco pacientes. Na série de Hawkins *et al.* (1987), o diagnóstico foi perdido pelo primeiro médico na maioria dos casos, e a radiografia axilar confirmou a luxação em todos eles e permitiu estimar o tamanho do defeito. A revisão sistemática de Kelly *et al.* (2019), com 182 pacientes, mostrou que as crises convulsivas foram a causa mais frequente (38%) e que o atraso diagnóstico é comum, com intervalos que chegaram a 25 anos. A rotação externa bloqueada, como a deste paciente (−10°), é um achado que deve levantar a suspeita e motivar a imagem adequada (HATZIS *et al.*, 2001). Como o paciente tinha instabilidade recorrente bilateral, vale lembrar que a instabilidade posterior é frequentemente não reconhecida e abrange desde a subluxação até a luxação travada (MILLETT *et al.*, 2006; MORODER; SCHEIBEL, 2017), o que reforça a necessidade de investigar a causa de base e de acompanhar o ombro contralateral.

Preservar a articulação. Com defeito de 27% da superfície articular e paciente de 32 anos, optou-se por reconstruir o defeito em vez de substituir a articulação. Os defeitos acima de 20% costumam exigir cirurgia, e a artroplastia é reservada, em geral, para os defeitos maiores que 45% a 50% (VAN DER LIST; WATERMAN, 2024). A necessidade de artroplastia é fator de pior prognóstico (ROBINSON; ADERINTO, 2005); na série de Hawkins *et al.* (1987), a hemiartroplastia teve sucesso em 6 de 9 ombros, com três revisões, e a meta-análise de Crowley *et al.* (2023) encontrou correlação entre a duração da luxação e a necessidade de revisão após a artroplastia. Mittal *et al.* (2022), em 16 luxações posteriores crônicas, indicaram a McLaughlin modificada para os defeitos menores que 50% e a hemiartroplastia para os maiores, sem recorrência de instabilidade em 27 meses de seguimento médio. As faixas de tamanho variam entre os autores, e a escolha deve considerar também a idade, o tempo de luxação e o estado da cartilagem (AYDIN *et al.*, 2019).

A técnica e a fixação. A técnica de McLaughlin original, de 1952, transfere o tendão do subescapular para o defeito (SHEVATE *et al.*, 2023). Na modificação, leva-se também o tubérculo menor, por via deltopeitoral (KONDA *et al.*, 2017). Na série de Hawkins *et al.* (1987), a transferência do tubérculo menor teve sucesso em 4 de 4 ombros, e a do subescapular, em 4 de 9. A revisão sistemática de Berk *et al.* (2024), com 97 ombros em nove estudos e defeitos de 20% a 50%, encontrou resultados clínicos e radiográficos favoráveis: escore de Constant ponderado de 75, escore UCLA de 29, EVA de 1,9, integração óssea do tubérculo menor em todos os pacientes, complicação em 1% (migração de parafuso) e reluxação em 2,1% (dois pacientes epilépticos), com melhores resultados quando o tempo entre a lesão e a cirurgia é menor. Castagna *et al.* (2009) consideram a técnica reprodutível, inclusive em luxações travadas há mais de seis meses e com defeitos de até 50%, e Khira e Salama (2017) acrescentaram enxerto de crista ilíaca em 12 pacientes, sem recorrência em 30 meses. Aparicio *et al.* (2000) trataram dois ombros luxados há mais de seis meses com a técnica de McLaughlin modificada por Hawkins, e todos os sete ombros de sua série tiveram bom resultado funcional, sem recorrência, em seguimento mínimo de pouco mais de dois anos.

Diferentes fixações são descritas: parafusos e fios (XIONG *et al.*, 2023), âncora de dupla fileira com tenodese do subescapular (VELASQUEZ GARCIA, 2022), âncora com parafuso canulado (SHEVATE *et al.*, 2023) e reparo do subescapular com âncora associado à transferência do tubérculo menor (MOUSSA; BOYKIN; EARP, 2013) (Tabela 2). Neste caso, associaram-se duas âncoras, com fios amarrados ao tendão, e dois parafusos corticais, o que, segundo a equipe cirúrgica, aumentou a resistência da montagem e evitou a rotação do fragmento. Essa combinação segue a lógica das séries que usaram parafusos e das que usaram âncoras, mas não foi comparada com outras fixações.

Resultado funcional. Os ganhos obtidos em cerca de 3 meses (EVA de 7 para 1, elevação ativa de 50° para 90° e rotação externa de −10° para 30°) vão na mesma direção dos resultados descritos, mas ficam abaixo das médias ponderadas de Berk *et al.* (2024) para o seguimento final (flexão anterior de 154° e rotação externa de 64°). Essa diferença é esperada pelo seguimento curto deste paciente e indica que o resultado funcional ainda deve ser reavaliado.

Tabela 2 – Estudos sobre a técnica de McLaughlin e suas modificações em luxações posteriores negligenciadas e este relato.

Estudo	Casos	Defeito	Técnica	Desfecho relatado
Hawkins *et al.* (1987)	41 luxações (40 pacientes)	Estimado pela radiografia axilar	Subescapular (n = 9); tubérculo menor (n = 4)	Sucesso em 4/9 e em 4/4, respectivamente
Xiong *et al.* (2023)	5	30–40%	Tubérculo menor + osso artificial; 2 parafusos + 2 fios	Constant-Murley 46,0 → 85,8; seguimento médio de 19,8 meses
Velasquez Garcia (2022)	1 (49 anos)	31%	Tubérculo menor + tenodese do subescapular; âncora de dupla fileira	Bom resultado
Shevate *et al.* (2023)	1	Não informado no resumo	Tendão + tubérculo menor; âncora + parafuso canulado	Fixação estável
Arafa; Abdelbadie (2019)	13 ombros	20–50%	*Dual subscapularis*	UCLA bom/excelente em 8 e regular/ruim em 5
Khira; Salama (2017)	12	Não informado no resumo	McLaughlin modificada com enxerto de crista ilíaca e parafusos	UCLA médio de 30; sem recorrência em 30 meses
Mittal *et al.* (2022)	16	< 50% (McLaughlin) e > 50% (hemiartroplastia)	McLaughlin modificada ou hemiartroplastia, conforme o defeito	VAS, UCLA e ASES melhoraram; sem recorrência em 27 meses
Berk *et al.* (2024), revisão sistemática	97 ombros (9 estudos)	20–50%	McLaughlin modificada	Constant 75; UCLA 29; EVA 1,9; complicação 1%; reluxação 2,1%
AlRashed *et al.* (2025)	1 (31 anos)	Lesão com mais de 10 meses	McLaughlin modificada com tubérculo menor	Melhora clínica
Este relato	1 (32 anos)	27%	Tubérculo menor; 2 âncoras + 2 parafusos	EVA 7 → 1; elevação 50° → 90°; ~3 meses

Fonte: elaborada pelos autores a partir dos resumos dos artigos (PubMed).

Limitações. Trata-se de um relato de caso único, sem grupo comparador, com seguimento curto (cerca de 3 meses), o que não permite avaliar complicações tardias, como necrose avascular e artrose da cabeça umeral. Xiong *et al.* (2023) acompanharam os pacientes por 19,8 meses em média, e Khira e Salama (2017), por 30 meses. Os desfechos aqui descritos são a EVA e a amplitude de movimento, sem escore funcional validado, como o Constant-Murley ou o UCLA, usados em outras séries. Além disso, o laudo da TC de controle descreve irregularidades corticais e subcondrais na face anterior da cabeça umeral, achado que deve ser acompanhado.

4 CONCLUSÃO

A técnica de McLaughlin modificada, com o tubérculo menor fixado por âncoras e parafusos, mostrou-se eficaz neste caso de luxação posterior negligenciada com lesão de Hill-Sachs reversa, com redução da dor, ganho de movimento e estabilidade glenoumeral no seguimento de cerca de 3 meses. O caso reforça a importância do diagnóstico precoce da luxação posterior, que deve ser suspeitada diante de rotação externa bloqueada, sobretudo após crise convulsiva, choque elétrico ou trauma. Estudos com mais casos e seguimento mais longo são necessários para definir o lugar dessa técnica e da fixação combinada.

ASPECTOS ÉTICOS

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa pela Plataforma Brasil em 27/10/2026 (instituição proponente: Universidade Federal do Maranhão; pesquisador responsável: Dr. Ozimo Pereira Gama Filho), encontrando-se em validação documental. O paciente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que inclui a autorização para o uso das informações do prontuário, dos exames de imagem e das fotografias. As imagens não contêm nome, data de nascimento ou outros identificadores, e os rostos foram ocultados.

CONFLITO DE INTERESSES E FINANCIAMENTO

Os autores declaram não haver conflito de interesses. O trabalho não recebeu financiamento.

REFERÊNCIAS

ALRASHED, A. H. *et al.* A rare case of missed locked posterior shoulder fracture dislocation. *Journal of Surgical Case Reports*, [*S. l.*], v. 2025, n. 11, p. rjaf881, 2025. DOI: https://doi.org/10.1093/jscr/rjaf881.

APARICIO, G. *et al.* Neglected traumatic posterior dislocations of the shoulder: controversies on indications for treatment and new CT scan findings. *Journal of Orthopaedic Science*, [*S. l.*], v. 5, n. 1, p. 37-42, 2000. DOI: https://doi.org/10.1007/s007760050006.

ARAFA, M. S.; ABDELBADIE, A. The dual subscapularis procedure: a modified Hawkins' technique for neglected posterior fracture/dislocation of the shoulder. *European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology*, [*S. l.*], v. 29, n. 5, p. 999-1007, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/s00590-019-02417-3.

AYDIN, N. *et al.* Treatment options for locked posterior shoulder dislocations and clinical outcomes. *EFORT Open Reviews*, [*S. l.*], v. 4, n. 5, p. 194-200, 2019. DOI: https://doi.org/10.1302/2058-5241.4.180043.

BASAL, O.; DINCER, R.; TURK, B. Locked posterior dislocation of the shoulder: a systematic review. *EFORT Open Reviews*, [*S. l.*], v. 3, n. 1, p. 15-23, 2018. DOI: https://doi.org/10.1302/2058-5241.3.160089.

BERK, A. N. *et al.* Clinical and radiographic outcomes of the modified McLaughlin procedure for locked posterior dislocation of the shoulder: a systematic review. *JSES Reviews, Reports, and Techniques*, [*S. l.*], v. 4, n. 1, p. 8-14, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.xrrt.2023.08.007.

CASTAGNA, A. *et al*. Modified MacLaughlin procedure in the treatment of neglected posterior dislocation of the shoulder. *La Chirurgia degli Organi di Movimento*, [*S. l.*], v. 93, supl. 1, p. S1-S5, 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/s12306-009-0001-y.

CROWLEY, M. *et al*. Systematic review and meta-analysis of locked posterior dislocation of the shoulder treated with shoulder arthroplasty: improved outcomes for total shoulder arthroplasty are associated with increased age. *Orthopaedic Surgery*, [*S. l.*], v. 15, n. 7, p. 1730-1741, 2023. DOI: https://doi.org/10.1111/os.13758.

HATZIS, N. *et al*. The often overlooked posterior dislocation of the shoulder. *Texas Medicine*, [*S. l.*], v. 97, n. 11, p. 62-67, 2001.

HAWKINS, R. J. *et al*. Locked posterior dislocation of the shoulder. *The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume*, [*S. l.*], v. 69, n. 1, p. 9-18, 1987.

KELLY, M. J. *et al*. The aetiology of posterior glenohumeral dislocations and occurrence of associated injuries: a systematic review. *The Bone & Joint Journal*, [*S. l.*], v. 101-B, n. 1, p. 15-21, 2019. DOI: https://doi.org/10.1302/0301-620X.101B1.BJJ-2018-0984.R1.

KHIRA, Y. M.; SALAMA, A. M. Treatment of locked posterior shoulder dislocation with bone defect. *Orthopedics*, [*S. l.*], v. 40, n. 3, p. e501-e505, 2017. DOI: https://doi.org/10.3928/01477447-20170308-07.

KONDA, S. R. *et al*. Posterior fracture dislocation of the shoulder: a modified McLaughlin procedure. *Journal of Orthopaedic Trauma*, [*S. l.*], v. 31, supl. 3, p. S36-S37, 2017. DOI: https://doi.org/10.1097/BOT.0000000000000900.

MILLETT, P. J. *et al*. Recurrent posterior shoulder instability. *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, [*S. l.*], v. 14, n. 8, p. 464-476, 2006. DOI: https://doi.org/10.5435/00124635-200608000-00004.

MITTAL, R.; JAIN, S.; GAMANAGATTI, S. Chronic posterior dislocation of shoulder. *Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma*, [*S. l.*], v. 31, p. 101926, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcot.2022.101926.

MORODER, P.; SCHEIBEL, M. ABC classification of posterior shoulder instability. *Obere Extremität*, [*S. l.*], v. 12, n. 2, p. 66-74, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s11678-017-0404-6.

MOUSSA, M. E.; BOYKIN, R. E.; EARP, B. E. Missed locked posterior shoulder dislocation with a reverse Hill-Sachs lesion and subscapularis rupture. *American Journal of Orthopedics*, [*S. l.*], v. 42, n. 12, p. E121-E124, 2013.

ROBINSON, C. M.; ADERINTO, J. Posterior shoulder dislocations and fracture-dislocations. *The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume*, [*S. l.*], v. 87, n. 3, p. 639-650, 2005. DOI: https://doi.org/10.2106/JBJS.D.02371.

SHEVATE, I. *et al*. A case of modified McLaughlin procedure in neglected posterior shoulder fracture dislocation. *Cureus*, [*S. l.*], v. 15, n. 1, p. e34356, 2023. DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.34356.

UPPAL, H. S. *et al*. The management of bilateral posterior fracture dislocations of the shoulder: a case series illustrating management options. *Shoulder & Elbow*, [*S. l.*], v. 8, n. 2, p. 111-117, 2016. DOI: https://doi.org/10.1177/1758573215626105.

VAN DER LIST, J. P.; WATERMAN, B. R. Humeral head reconstruction of reverse Hill-Sachs lesions. *Instructional Course Lectures*, [*S. l.*], v. 73, p. 559-571, 2024.

VELASQUEZ GARCIA, A. Modified McLaughlin procedure using a double-row suture anchor for chronic locked posterior shoulder dislocation: a case report. *JBJS Case Connector*, [*S. l.*], v. 12, n. 3, 2022. DOI: https://doi.org/10.2106/JBJS.CC.22.00213.

XIONG, F. *et al*. A novel modified McLaughlin surgery for treating locked chronic posterior shoulder dislocation. *BMC Musculoskeletal Disorders*, [*S. l.*], v. 24, n. 1, p. 114, 2023. DOI: https://doi.org/10.1186/s12891-023-06221-3.